

جوستاف روسي انترناسيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : شيماء محمد وهبه على

المحافظة : الجيزة

الحي / المدينة : سته اكتوبر

العنوان : *****

رقم البطاقة : 28108270104585 رقم التليفون : 01228910589

تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 27-08-1981 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (_____)

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مسيح ذري على العظام [12966] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة:

الوظيفة:

الوظيفة:

التوقع:

التوقع:

التوقيع:

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / د ----- / د ----- / د. | ----- / د. |

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

قسم :

نفقات :

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: شيماء محمد وهبه علي National ID: 28108270104585	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bone scintigraphy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


 جمهورية مصر العربية
 وزارة الداخلية
 شيماء
 محمد وهبة عني
 ٤٥٧ ب الفردي من القوات المسلحة
 ٦ أكتوبر - الجيزة
 ٢٠١٩/٠٨/٢٧ ٢٨١٠٨٢٧٠١٠٤٥٨٥
 108614947

٢٠١٩/٠٨ ٢٨١٠٨٢٧٠١٠٤٥٨٥
 حاصلة على بكالوريوس علوم شيماء
 أنشئ منسمة متروجة
 محمد ربيع محمد عفيفي
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٥/٢٥



Name: *Shaimaa Mohamed Wahba*
Referred by: *Prof. Ahmed Abd Al Hady*

ID: 4667197
Date: 11/03/2026

¹⁸F-FDG PET/CT examination

Clinical Indication:

- Patient with history of left breast cancer, under target and hormonal therapy, for assessment.

Administered activity: 222 MBq. ¹⁸F-FDG

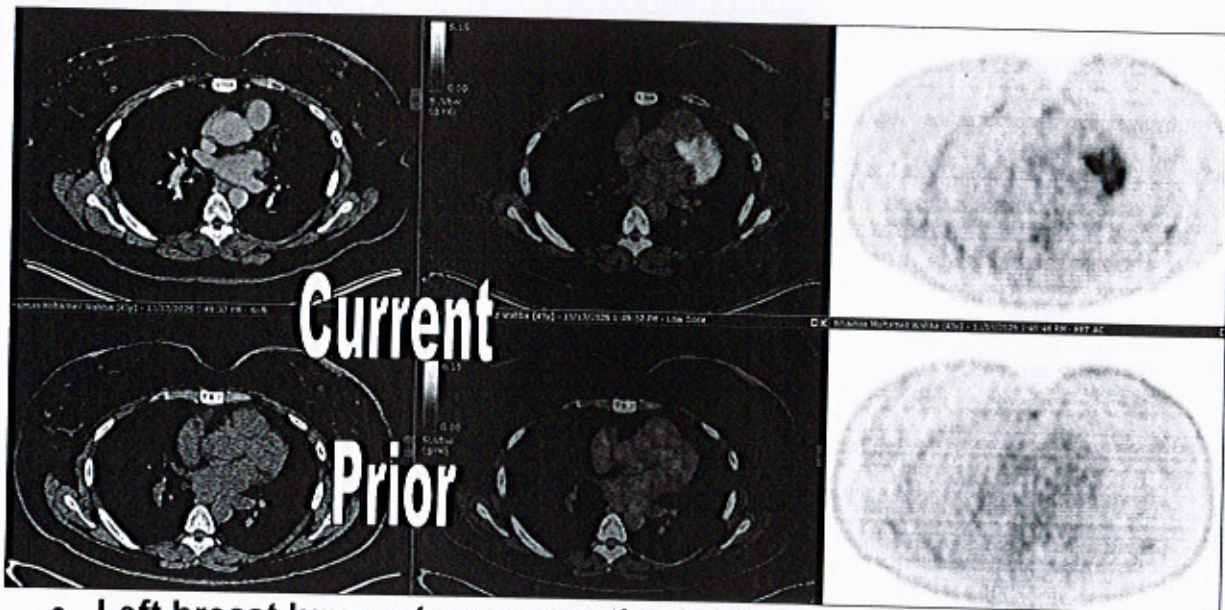
B.G.L.: 89 mg/dL

Examination protocol:

- A Whole-body PET/CT study was obtained from skull vertex to the mid-thigh using a low dose non contrast CT for attenuation correction
- Diagnostic multislice CT examination after IV contrast administration of the same region.

Comparison was made to FDG PET/CT study dated 17/11/2025

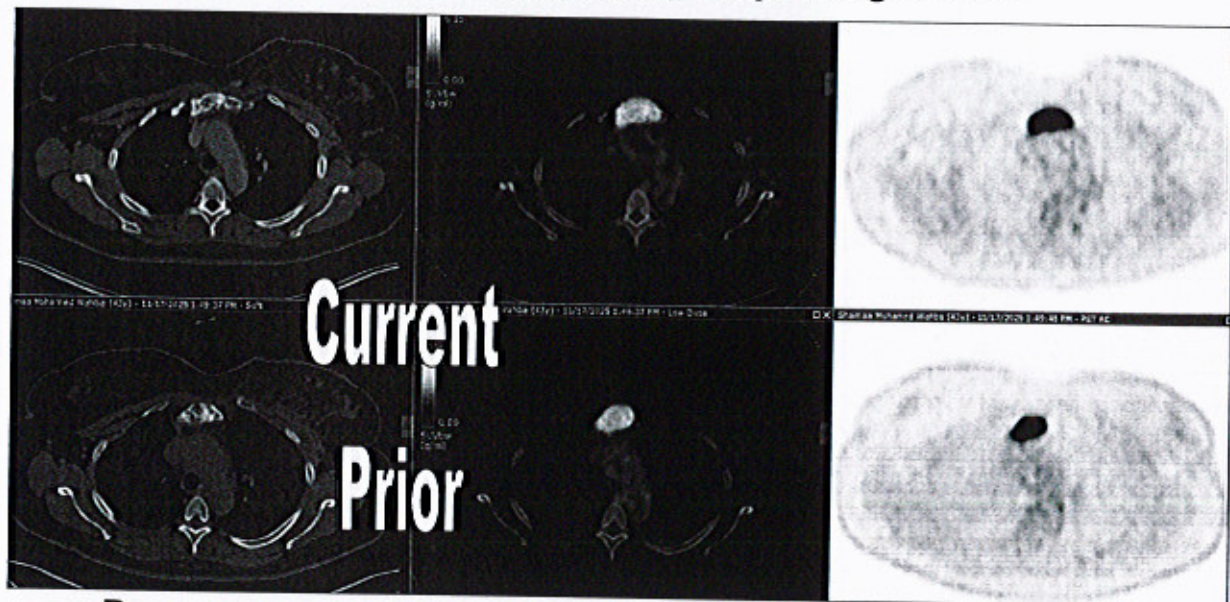
I. PET/CT Findings:



- Left breast lumpectomy operative bed:
 - No FDG avid lesions.
 - **Still noted** low grade FDG activity by diffuse skin thickening, measures 7 mm compared to 9 mm.
- Right breast: no FDG avid lesions.

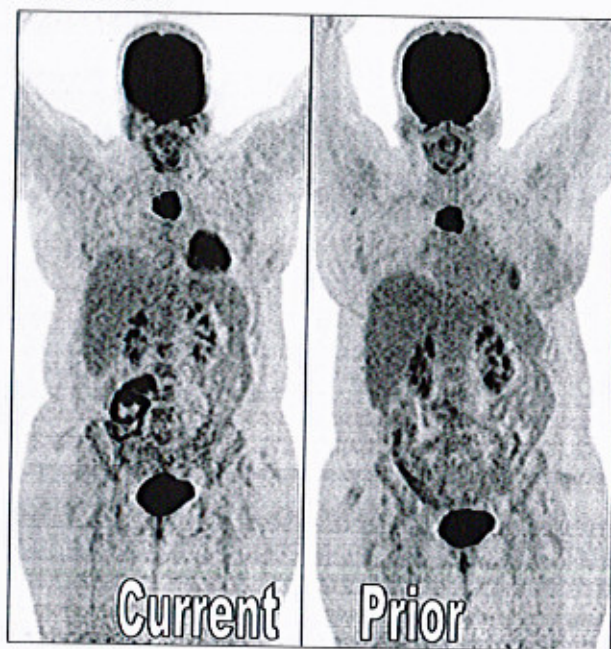
Name: شيماء محمد وهبه على		GUSTAVE ROUSSY	
MR. : 2112			
Detailed Medical Report			
			السيد
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
		رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها			
BREAST CANCER MET TO BONE ON IBRANCE FASLODEX LABS ACCEPTED LATEST PET CT ON 11/3 = SD, ONLY METABOLIC MILD PROGRESSION OF STERNAL BONY LESION, (PT RENEWED TTT WITH PET CT) BREAST CANCER MET TO BONE FOR IBRANCE FASLODEX AND ZOLADEX TODAY LABS HB 11.8 PLT 243 TLC3.1/1 prem left breast cancer left bcs on 9/2023 pt2 n 0/16 mo idc 2 er7/8 pr5/8 her2-ve ki 15-205 rec ac taxol st zoladex tam rec port rt to sternum till 7/2025 sternal pd met activity st fasoldex ibrance from 9/2025 pet ct 3/2026 mild metabolic progression of sternal lesion for new pet ct for zometa fasoldex ibrance 125 1x1x21 today for zoladex , ibrance 125 mg ,faslodex >>labs >> accepted PET CTs 19-7-2026 compared to11-3-2026 >> -metabolic regression regarding osseous lesion suv max 6.3 VS 18.3 - No newly developed lesions			
تحريراً في ,			
		التاريخ :	19-09-2026
		الوقت :	
		هنا أسامه عبد الرحيم عبد البر	الطبيب المعالج :
يعتمد ,			

- **Left axillary dissection operative bed:** no FDG avid or pathologically enlarged LNs.
- **Lymph nodes:**
 - The previously noted bilateral cervical lymph nodes are *less distinct*.
 - *No other FDG avid or pathologically enlarged LNs.*



- **Bone marrow:**
 - *No significant metabolic change* of the previously noted lytic lesion with sclerotic changes in the manubrium sterni (SUVmax 18.6 compared to 16.1) as well as the sclerotic lesion in L3 with SUVmax 3.1 compared to 2.8.
 - *Mild metabolic progression* of the previously noted lytic lesion with sclerotic rim in the sternal body with SUVmax 3.7 compared to 2.4

- **Still noted:**
 - Hypometabolism of the lower cervical and upper dorsal region, *post-radiation sequel*.
 - Sclerotic lesion at L2 with no significant FDG activity.
 - Tiny bony island in the right iliac bone.
- **Lungs:**
 - No FDG avid pulmonary nodules.
 - **Still noted** non-FDG avid sub-pleural reticulations at left upper lobe, *post radiation sequel*.
- **Liver:** measures 18.6 cm compared to 21.2 cm with no focal FDG avid lesions. No dilated biliary radicles. Patent portal vein.
- **Spleen:** measures 12.6 cm compared to 12.9 cm with no focal FDG avid lesions.
- **Pelvic organs:** no FDG avid lesions.
- **Brain:** no focal FDG avid lesions.



II. Diagnostic CT Findings:

- No pleural, pericardial or peritoneal collections.
- The pancreas, adrenals, kidneys, aorta and IVC appear unremarkable.
- Cholecystectomy clips.

OPINION:

Follow-up study demonstrates:

- No significant metabolic change of the previously noted manubrium sterni lesion as well as L3 vertebral lesion.
- Mild metabolic progression of the previously noted sternal body lesion.
- No newly developed hypermetabolic lesions.

Radiologist
Dr. Mohamed Hoseny, MD

Nuclear Medicine Physicians
Dr. Sherif El Refaie, MD, EBNM
Dr. Omnia Alaa, MSc

Patient Name	شيماء محمد وهبه	Age	43
Sex	f	Special habits	-
Family History	-	Comorbidity	-
Surgical History	-	Telephone	01228910589
Menopausal Status	-	Marital Status	married
ID	28108270104585	Medical ID	1186/2025
Date	11/8/2025	Reason of MDT	-

Medical Report

Pathology: Bx-> (9/2023) BCS -> IDC G II

ER 7 /8 PR 5/ 8 HER 2 -ve KI67: 15-20%

T N M: T2 N0

0/16

S.M:

Metsworkup:

Patient was on tamoxefen , zoladex (3/2024)

On FU PET CT showed Disease Progression in sternal lesion -> for 2nd line
Ibrance +arimidix

Patient took 3 cycles of ibrance + aramidix then stopped (due to paperwork)

Recommendations:

MDT DECISION

For Faslodex + ibrance + zoladex

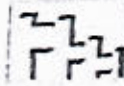
Name

د. نرمين مصطفى

Signature

د. نرمين مصطفى
11/8/2025

11/8/2025



Name	شيماء محمد وحيبة	Age	36Y	Code	816-23
Referred by	أ.د/ عمرو كمال	Date of receiving specimen	19/2023		
Patient ID		Sex	female		
Clinical data	Left breast mass.				
Specimen	1). Excision biopsy. 2). Axillary LNs.				

PATHOLOGY REPORT

GROSS: Two specimens: 1) A sector of breast tissue 11x7x5 cm with partial skin covering 5x3 cm. Serial cuts revealed an ill-defined firm grayish white mass measured 2.2x2 cm, located (5, 2, 1.5, 1.5, and 2 cm) from (lateral, medial, superior, inferior and deep) resection margins respectively. 2) Axillary fatty tissue specimen entangling 16 lymph nodes measured up to 1.5 cm in diameter.

MICROSCOPY: 1) Serial sections examined from the detected breast mass reveal tumor tissue formed of irregular groups, nests and malformed ductal structures of malignant epithelial ductal cells, showing moderate nuclear anaplasia, surrounded by stromal desmoplasia. No identified DCIS component, lymphovascular invasion or perineural invasion. Sections examined from all resection surgical margins are tumor-free. 2) The dissected axillary lymph nodes reveal no tumor deposits (0/16).

DIAGNOSIS: Left breast: 1). Excision biopsy. 2). Axillary LNs:

- Infiltrating ductal carcinoma, grade II.
- Free all resection margins.
- Free axillary LNs (0/16).
- Stage: pT2, pN0.

Consultant of Pathology Unit
Ass Prof. Dr.: Mohamed Sherif, MD
Dr. Mostafa Fawzy, MD

فاكس : 8500920

ت: 8500923/8500922/8500921

العنوان : مدينة الشيخ زايد - طريق مدينة أكتوبر



ImmunohistoChemistry report

Report Number: m2160

Female :	النوع	شيماء محمد ودية	اسم المريض :
03/08/2023 12:08 :	العنوان	42 Y	السن :
13/08/2023 11:44 :	تاريخ استلام العينة	مستشفى الشيخ زايد التخصصي	تاريخ اخذ العينة :
	تاريخ التقرير	مستشفى الشيخ زايد التخصصي	طالب التحليل :
			عناية :

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (IE2)Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by: - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX / XT .
Sample recieved was treated by: - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: moderate nuclear staining of > 60 % of tumour cells (tiny fragment)
PR: moderate nuclear staining of 20 % of tumour cells (tiny fragment)
HER2/neu protein over expression : NO membrane staining of tumor cells (tiny fragment) .
Ki67 :positive nuclear staining of 15 - 20 % of tumour cells (tiny fragment)

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 7 / 8)
PR: POSITIVE (SCORE 5 / 8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : NEGATIVE
#KI67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS 15 - 20 % .

Pathologist:

د. نورا ماهر

Lab Director:

د. نورا ماهر

صورة قسم زليل
من
م. م. م.
وزارة الصحة
الإدارة المركزية للمعامل

19 El-sheikh Rehan Street, Abeideen, Cairo
Tel.(165)7948544 -7950095 Fax. (202)7948544
Mobile . 01144297292
website: http://www.healthlabs.net
email: pathologychl@yahoo.com
facebook: قسم الشلوجي - الإدارة المركزية للمعامل

■ This Test Is Not Accredited By EGAC Nor Recognized By ILA .

بسم الامانة يسل العينة لمدة 30 يوم من تاريخ استلامها